KINESIOLOGIA STUDIO · USO INTERNO · DOTT. DAVIDE SCUDERI

Schema differenziale

Lombosacrale, cervicale e spalla: i quadri più comuni, cosa chiedere, cosa verificare, cosa li esclude e in che direzione lavorare. Pensato per arrivare in dieci minuti a una ipotesi di lavoro, non a una diagnosi: quella spetta al medico.

Prima le bandiere rosse, sempre | Aggiornato novembre 2026

Il metodo, in una pagina

La stessa sequenza per tutte e tre le regioni. L'anamnesi fa l'80% del lavoro: i test servono a confermare o smontare l'ipotesi che le domande hanno già costruito.

Le cinque domande che orientano

1. **Dove, con un dito.**
   Un dito su un punto = struttura locale (sacroiliaca, faccetta, acromion-claveare). Una mano aperta o "qui dentro" = riferito o diffuso.
2. **Cosa lo peggiora e cosa lo migliora.**
   Flessione contro estensione, seduto contro in piedi, movimento contro riposo, carico contro scarico. È la domanda più discriminante di tutte.
3. **Fin dove arriva.**
   Sotto il ginocchio o sotto il gomito, con formicolio o debolezza, vuol dire nervo. Sopra, è più spesso riferito da articolazione, disco o muscolo.
4. **Notte e mattina.**
   Rigidità mattutina oltre mezz'ora e dolore nella seconda metà della notte che migliora alzandosi: infiammatorio. Dolore notturno che non cambia in nessuna posizione: bandiera rossa.
5. **Da quanto e come è iniziato.**
   Trauma, gesto preciso, oppure insidioso. Episodi ricorrenti con "cedimenti" parlano di controllo motorio, non di struttura.

Come leggere i test

- **Un test da solo non basta.** Conta il cluster: più test della stessa struttura, concordi con l'anamnesi.
- **Cerca prima di escludere, poi di confermare.** I test sensibili servono a togliere (SLR negativo: radicolopatia improbabile). I test specifici servono a mettere (Laslett 3 su 5: sacroiliaca probabile).
- **Riproduci il suo dolore, non un dolore.** Un test è positivo solo se evoca il sintomo per cui è venuto, nello stesso punto.
- **Ritesta a fine seduta.** Se il test positivo non cambia dopo il trattamento, o hai trattato la struttura sbagliata o la tecnica sbagliata. Cambia ipotesi, non insistere.

Quando la risposta è "prima il medico"

Qualsiasi bandiera rossa, un deficit neurologico (forza, riflessi, sensibilità), un dolore che non risponde a nessuna posizione, un sospetto infiammatorio, o nessun miglioramento dopo tre o quattro sedute ben mirate. Nel programma Che Postura corrisponde al piano "Prima il medico".

Lombosacrale

Il più delle volte le domande due e tre separano già disco, faccette, sacroiliaca e nervo. Il resto è il gruppo che si confonde con la sacroiliaca e che il thrust non risolve: cerniera dorsolombare, nervi cluneali, controllo motorio, anca.

Bandiere rosse: ferma tutto e manda al medico

- **Cauda equina.** Difficoltà a urinare o incontinenza nuova, anestesia a sella, debolezza bilaterale alle gambe. Pronto soccorso lo stesso giorno.
- **Frattura.** Trauma, età oltre i 70, osteoporosi, cortisone prolungato, dolore acuto centrale alla percussione delle spinose.
- **Tumore o infezione.** Storia di tumore, calo di peso senza motivo, febbre, dolore notturno non posizionale, immunosoppressione, uso di droghe endovena.
- **Aneurisma aortico.** Oltre 60 anni, fumatore, dolore profondo pulsante, massa addominale pulsante. Non palpare in profondità, manda.
- **Viscerale.** Dolore che non cambia con nessuna posizione o movimento, legato al ciclo, ai pasti o alla minzione: rene, ginecologico, pancreas.
- **Deficit neurologico progressivo.** Perdita di forza che peggiora in giorni (piede cadente, non sale sulle punte). Visita urgente, niente rinforzo.

L'ordine dei test, dopo le domande

1. **Neurologico veloce** se il dolore scende sotto il ginocchio: forza (tibiale anteriore, estensore dell'alluce, tricipite surale), riflessi rotuleo e achilleo, sensibilità L4, L5, S1. Poi SLR e Slump.
2. **Movimenti ripetuti**: dieci flessioni in piedi, dieci estensioni prone. Centralizza o periferizza? Questo separa disco e faccette, e dice subito in quale direzione lavorare.
3. **Cluster di Laslett** per la sacroiliaca: distrazione, compressione, thigh thrust, sacral thrust, Gaenslen. Sotto tre positivi su cinque, la sacroiliaca esce.
4. **Cerniera e cresta**: pinza-rotolamento sopra la cresta, pressione laterale sulle spinose T11-L2, punto crestale a circa 7 cm dalla linea mediana con Tinel.
5. **Controllo motorio**: Active Straight Leg Raise con e senza compressione del bacino, prone instability test, estensione d'anca prona secondo Janda.
6. **Anca**: FADIR, FABER, rotazione interna a 90° di flessione, Thomas. Un'anca rigida e dolente in rotazione interna simula una lombalgia bassa.

Discogenico, intolleranza alla flessione

L4-L5, L5-S1 · IL PIÙ COMUNE SOTTO I 50

COSA DICE

- Peggio seduto, piegato in avanti, al mattino, con tosse e starnuto, nell'alzarsi dalla sedia.
- Meglio in piedi, camminando, sdraiato.
- Dolore centrale o monolaterale, può riferire al gluteo e alla coscia senza scendere sotto il ginocchio.

COSA VERIFICARE

- Flessioni ripetute in piedi peggiorano o periferizzano.
- Estensioni ripetute prone centralizzano o migliorano.
- Flessione da seduto dolorosa, estensione libera.
- SLR e neurologico per escludere la componente radicolare.

COSA LO ESCLUDE

- Migliora in flessione e peggiora in estensione: guarda le faccette.
- Nessuna direzione cambia il dolore: cerca altrove.

DIREZIONE DEL LAVORO

- Preferenza direzionale in estensione, hip hinge, camminata.
- Stop agli allungamenti in flessione (ginocchia al petto, ischiocrurali da seduto).
- Resistenza del tronco (McGill), poi glutei.

Radicolopatia lombare

NERVO, NON MUSCOLO

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Il dolore alla gamba è peggiore di quello alla schiena. • Scende sotto il ginocchio lungo una striscia, con formicolio, "spilli", a volte debolezza. • Peggio seduto e in flessione, con la tosse.	• SLR positivo tra 30° e 70°, peggiora con dorsiflessione o flessione del collo. SLR crociato: molto specifico. • Slump positivo. • Riflessi rotuleo (L4) e achilleo (S1), forza di tibiale anteriore (L4), estensore dell'alluce (L5), tricipite surale (S1), sensibilità per dermatomero.	• SLR negativo e dolore che non scende sotto il ginocchio: molto improbabile. • Dolore diffuso non dermatomerico: riferito, non radicolare.	• Centralizzazione con movimenti ripetuti, posizioni di scarico. • Niente stretching del nervo, niente flessione sotto carico. • Deficit di forza o progressivo: medico prima di tutto.

Faccette, intolleranza all'estensione

OLTRE I 50, O GIOVANE IPERLORDOTICO

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Peggio in piedi fermo, in estensione, girandosi nel letto, nel tratto finale del rialzarsi. • Meglio seduto, piegato in avanti, con le ginocchia al petto. • Rigidità mattutina breve, sotto la mezz'ora. Dolore paraspinale a un dito, può riferire a gluteo e coscia.	• Estensione con rotazione omolaterale (Kemp) riproduce il dolore locale. • Estensioni ripetute peggiorano, flessioni ripetute migliorano. • Pressione postero-anteriore sul segmento dolente.	• Centralizzazione in estensione: è disco. • Dolore sotto il ginocchio con segni neurologici.	• Preferenza in flessione, mobilizzazione segmentaria. • Addominali, glutei, flessori d'anca da allungare (Thomas). • Insegna a non "appendersi" sulla lordosi in piedi.

Stenosi del canale

OLTRE I 60

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Gambe pesanti o dolenti camminando, che passano fermandosi piegato in avanti o seduto. Spinge il carrello della spesa. • In bicicletta sta bene. • Spesso bilaterale, sintomi vaghi, più pesantezza che dolore.	• Marcia a due stadi: cammina in piano finché compaiono i sintomi, poi in salita o piegato: in flessione resiste di più. • Estensione mantenuta 30 secondi peggiora, flessione migliora. • Polsi periferici e colore della cute per escludere la claudicatio vascolare.	• Sintomi uguali in bici e a piedi, polsi deboli: vascolare, medico. • Sotto i 50 anni è raro.	• Preferenza in flessione, bici, camminata a intervalli. • Mobilità d'anca in estensione, forza di glutei e gambe. • Diagnosi e imaging dal medico, se non già fatti.

Sacroiliaca

MENO FREQUENTE DI QUANTO SEMBRI

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Indica con un dito un punto subito sotto e dentro la SIPS (segno di Fortin). Dolore monolaterale. • Peggio salendo le scale, alzandosi dalla sedia, girandosi nel letto, in appoggio su una gamba. • Gravidanza, post-parto, trauma con un piede a terra, dismetria.	• Cluster di Laslett: almeno tre su cinque riproducono il suo dolore. • ASLR: gamba pesante che migliora comprimendo il bacino. • Nessun dolore sopra L5, nessuna centralizzazione con movimenti ripetuti.	• Meno di tre su cinque, o centralizzazione con i movimenti ripetuti: è disco o faccette. • Dolore alla cresta iliaca piuttosto che alla SIPS: cerniera o cluneali.	• Mobilizzazione o thrust una volta, poi ritest: se non cambia, cambia ipotesi. • Stabilità: glutei, addominali, latissimo (chiusura di forza). • Cintura pelvica temporanea se ASLR migliora con compressione.

Cerniera dorsolombare (Maigne)

LA FALSA SACROILIACA

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore sulla cresta iliaca posteriore, a volte all'inguine o sul trocantere, "sciatica che non scende". • Peggio in flessione, seduto a lungo, in rotazione. • Nessun dolore alla cerniera stessa: il paziente non sa che viene da lì.	• Pinza-rotolamento della cute sopra la cresta: dal lato sintomatico è nettamente più doloroso e ispessito. • Pressione laterale sulle spinose e sulle faccette T11-L2 che riproduce il dolore alla cresta. • Punto crestale dolente, palpazione lombare bassa e sacroiliaca negative.	• Pinza-rotolamento uguale da entrambi i lati. • Laslett positivo e cerniera silente.	• Mobilizzazione o manipolazione della cerniera dorsolombare, non della sacroiliaca. • Skin rolling e lavoro sulla fascia toracolombare. • Mobilità in estensione e rotazione del tratto dorsale basso, respiro costale.

Nervi cluneali superiori

IL PUNTO SULLA CRESTA

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore sulla cresta iliaca a 7 cm dalla linea mediana, che irradia al gluteo, a volte alla coscia posteriore. • Peggio in flessione, rotazione, seduto e in piedi a lungo. Migliora con il calore. • Spesso trattato come sacroiliaca o lombare senza risultato.	• Pressione sul punto crestale riproduce il dolore e l'irradiazione, Tinel positivo. • Flessione del tronco con inclinazione controlaterale evoca il sintomo. • Laslett negativo, neurologico normale.	• Punto crestale non dolente. • Centralizzazione con movimenti ripetuti.	• Liberazione della fascia nel punto di passaggio, non pressioni profonde sul dolore. • Scorrimento neurale dolce, mobilità dorsolombare. • Se persiste, il medico può confermare con infiltrazione.

Controllo motorio, instabilità funzionale

QUELLO CHE IL THRUST NON CAMBIA

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Episodi ricorrenti, "mi si blocca", cedimenti, un "clic" nel rialzarsi. • Dolore nelle posture mantenute, non nel movimento. Sta meglio quando si muove e peggio quando sta fermo. • Migliora per un giorno dopo la manipolazione, poi torna uguale.	• ASLR: gamba pesante, migliora con compressione manuale del bacino. • Prone instability test positivo. • Movimenti aberranti nel rialzarsi dalla flessione (si aiuta con le mani sulle cosce). • Estensione d'anca prona (Janda): gluteo che parte tardi; multifido che non si attiva.	• ASLR negativo, nessun movimento aberrante, buona attivazione. • Dolore chiaro in una sola direzione: è meccanico direzionale.	• Attivazione di trasverso, multifido e glutei, poi resistenza e integrazione nel gesto. • Meno manipolazione, più allenamento: è il lavoro per chi segue il movimento. • Ipermobilità (Beighton): niente allungamenti globali.

Anca che simula una lombalgia

GUARDA SEMPRE L'ANCA

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore all'inguine, a volte gluteo profondo o coscia anteriore. Segno della C: afferra l'anca con la mano a "C". • Peggio seduto in macchina, accavallando le gambe, mettendo le calze, in rotazione. • Zoppia, rigidità mattutina breve.	• FADIR positivo (flessione, adduzione, rotazione interna). • FABER con dolore inguinale e ginocchio che resta alto. • Rotazione interna ridotta a 90° di flessione, confronto con l'altra anca.	• Anca libera, simmetrica e indolore in tutte le direzioni. • FABER con dolore posteriore: guarda la sacroiliaca.	• Mobilità d'anca, capsula posteriore, forza di glutei e rotatori. • Niente flessione profonda sotto carico in fase dolorosa. • Rigidità marcata oltre i 50: imaging dal medico.

Infiammatorio (spondiloartrite)

REUMATOLOGO, NON STUDIO

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Sotto i 45 anni, inizio insidioso, da più di tre mesi. • Rigidità mattutina oltre la mezz'ora, dolore nella seconda metà della notte che migliora alzandosi. • Migliora con l'esercizio, non con il riposo. Gluteo alternante. Risponde bene ai FANS. Psoriasi, uveite, intestino infiammato in famiglia.	• Nessun test manuale decisivo: contano le domande. Quattro su cinque criteri di dolore infiammatorio fanno sospetto. • Schober ridotto, espansione toracica ridotta nei casi avanzati. • Laslett può essere positivo: non è prova di sacroiliaca meccanica.	• Dolore chiaramente meccanico: peggio con il carico, meglio con il riposo, nessuna rigidità mattutina prolungata.	• Lettera al medico con i criteri osservati, HLA-B27 e RM delle sacroiliache le decide lui. • Niente thrust. Mobilità e respiro sì, dopo la diagnosi, in coordinamento.

Miofasciale: quadrato dei lombi, glutei, piriforme

DIAGNOSI PER ESCLUSIONE

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore sordo, a fascia, riferito secondo mappe trigger (quadrato dei lombi su cresta e gluteo, medio gluteo sul sacro, piriforme sul gluteo e coscia posteriore). • Peggio stando a lungo in una posizione, meglio cambiando e con il calore.	• Punto trigger che riproduce il dolore riferito. • Tutto il resto negativo: movimenti ripetuti, Laslett, neurologico, anca. • Piriforme: FAIR positivo, dolore alla palpazione profonda, SLR negativo.	• Qualsiasi test strutturale positivo: il muscolo è il compenso, non la causa.	• Trattamento del muscolo, ma sempre chiedendosi perché lavora troppo: dismetria, anca rigida, gluteo inibito, respiro. • Se torna uguale dopo due sedute, la causa è altrove.

Cervicale

Prima lo screening di sicurezza, sempre, anche senza manipolare. Poi la domanda chiave: il dolore cambia muovendo il collo o muovendo la spalla? Il dolore interscapolare, quello di Laura, viene spesso dal cervicale basso.

Bandiere rosse: ferma tutto e manda al medico

- **Disfunzione vascolare cervicale.** Cefalea o dolore al collo nuovi e "diversi", con diplopia, vertigine, disartria, disfagia, nistagmo, nausea, parestesie al viso, svenimenti. Pronto soccorso.
- **Instabilità cervicale alta.** Artrite reumatoide, sindrome di Down, trauma recente, sensazione di "testa che cade", clunk, parestesie bilaterali. Niente manipolazioni, niente test di mobilità spinti.
- **Mielopatia.** Mani goffe, bottoni difficili, andatura insicura, iperreflessia, Hoffmann e Babinski positivi, clono. Visita urgente.
- **Frattura.** Trauma: regola canadese della colonna cervicale (oltre 65 anni, meccanismo pericoloso, parestesie agli arti). Imaging prima di tutto.
- **Tumore, infezione, cefalea a esordio esplosivo.** Storia di tumore, febbre, dolore notturno non posizionale, cefalea "la peggiore della vita".

L'ordine dei test, dopo le domande

1. **Screening di sicurezza**: anamnesi vascolare, stabilità (Sharp-Purser con cautela, legamenti alari), neurologico C5-T1 se c'è dolore al braccio.
2. **Movimenti attivi** con sovrappressione: quale direzione riproduce, dove va il dolore, rotazione sotto i 60°.
3. **Cluster di Wainner** per la radicolopatia: Spurling, distrazione, ULTT del mediano, rotazione omolaterale sotto 60°. Tre su quattro: probabile.
4. **Flexion-rotation test** per C1-C2 e flessione cranio-cervicale (CCFT) per i flessori profondi: cefalea e controllo.
5. **Spalla e torace**: se i movimenti della spalla a collo fermo cambiano il dolore, vai alla sezione spalla. Mobilità dorsale e scapola per il dolore interscapolare.
6. **Mandibola e respiro** quando c'è cefalea, serramento o respiro alto: apertura, deviazione, palpazione dei masticatori, schema respiratorio.

Cervicalgia meccanica, faccette e postura

LA PIÙ COMUNE

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore locale, a un lato, a volte riferito a trapezio superiore e scapola, senza scendere sotto il gomito. • Peggio dopo ore allo schermo, in estensione o rotazione, al mattino con rigidità breve. • Nessun formicolio.	• Movimenti attivi che riproducono il dolore in estensione o rotazione, con sovrappressione. • Pressione postero-anteriore sul segmento dolente, spesso C5-C6 o C2-C3. • Neurologico normale, Spurling negativo.	• Dolore sotto il gomito con segni neurologici. • Dolore che cambia muovendo la spalla a collo fermo.	• Mobilizzazione, dorsale alta compresa. • Flessori profondi (CCFT), trapezio inferiore, dentato, postazione di lavoro. • Mento indietro e pause: è la scheda di Laura.

Radicolopatia cervicale

C6 E C7 LE PIÙ FREQUENTI

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore al braccio peggiore di quello al collo, sotto il gomito, con formicolio alle dita (pollice e indice C6, medio C7, anulare e mignolo C8). • Peggio in estensione e rotazione verso il lato, tossendo. Meglio con la mano sulla testa (segno dell'abduzione).	• Cluster di Wainner: Spurling positivo, distrazione che allevia, ULTT del mediano positivo, rotazione omolaterale sotto 60°. • Riflessi bicipitale (C5-C6), tricipitale (C7), forza e sensibilità per miotomo e dermatomero.	• ULTT negativo e dolore che non scende sotto il gomito. • Dolore riprodotto dai movimenti della spalla, non del collo.	• Scarico: retrazione, trazione manuale, posizioni di apertura del forame. • Niente tensione neurale aggressiva, niente estensione sotto carico. • Deficit di forza: medico, prima di tutto.

Dolore interscapolare riferito dal cervicale

IL DOLORE "FRA LE SCAPOLE" DI LAURA

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore fra le scapole, sul bordo mediale, spesso a un lato, "come un chiodo", che non trova la posizione. • Peggio dopo ore di schermo, a volte con rigidità al collo che il paziente non collega. • Il massaggio sul punto dà sollievo per poche ore.	• Movimenti del collo con sovrappressione, in particolare estensione e rotazione, riproducono il dolore fra le scapole: segmento C5-C7 (mappa di Cloward). • Pressione sul cervicale basso che evoca il dolore interscapolare. • Forza di trapezio medio e inferiore, discinesia scapolare, mobilità dorsale.	• Collo libero e silente in tutte le direzioni: il dolore è locale (romboidi, trapezio medio sovraccaricati). • Dolore con il respiro profondo o lo sforzo: medico (cuore, polmone).	• Trattare il cervicale basso e il dorsale alto, non solo il punto dolente. • Trapezio inferiore e dentato anteriore, apertura del dorso, pettorali. • Lavoro posturale strutturato: è dove la seduta da sola non basta.

Cefalea cervicogenica

C1-C3

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Mal di testa a un lato che non cambia lato, parte dalla nuca e sale a tempia e occhio. • Scatenato da posizioni e movimenti del collo, pressione sulla nuca. Non pulsante, senza aura. • Rigidità del collo alta.	• Flexion-rotation test: rotazione a collo flesso sotto i 32° dal lato della cefalea. • CCFT: flessori profondi deboli, sternocleidomastoideo che prende il comando. • Pressione su C1-C2 e C2-C3 che riproduce la cefalea.	• Cefalea che cambia lato, pulsante, con aura, nausea e fotofobia: emicrania. • Qualsiasi segno vascolare o neurologico: bandiera rossa.	• Mobilizzazione C1-C3, suboccipitali. • Flessori profondi, scapola, postazione di lavoro. • Mandibola e occhi se il respiro e il serramento sono coinvolti.

Colpo di frusta e disturbi post-traumatici

TRAUMA RECENTE

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore diffuso al collo dopo un incidente, rigidità, cefalea, a volte vertigine, difficoltà di concentrazione, disturbi del sonno. • Paura di muovere il collo.	• Prima la regola canadese e l'imaging se indicato. • Stabilità alta, screening neurologico, test vascolare. • Mobilità attiva, CCFT, Joint Position Error (rimettere la testa al centro a occhi chiusi).	• Nessun trauma. Questo quadro esiste solo con un evento.	• Movimento precoce dolce, rassicurazione, niente collare. • Niente manipolazione nelle prime settimane. • Propriocezione, flessori profondi, graduale ritorno.

Stretto toracico

RARO, SPESSO SOVRADIAGNOSTICATO

COSA DICE

- Formicolio a tutta la mano o lato ulnare, pesantezza del braccio a lavorare con le mani in alto, mano fredda o pallida.
- Peggio con lo zaino, portando pesi, dormendo con il braccio sopra la testa.

COSA VERIFICARE

- Roos (braccia in alto, apri e chiudi le mani per 3 minuti) riproduce i sintomi.
- ULTT, palpazione degli scaleni e del piccolo pettorale.
- Adson e Wright hanno molti falsi positivi: da soli non valgono.

COSA LO ESCLUDE

- Sintomi in un dermatomero preciso: radicolopatia.
- Formicolio solo alle prime tre dita, di notte: tunnel carpale.

DIREZIONE DEL LAVORO

- Scaleni, piccolo pettorale, prima costa, respiro diaframmatico.
- Scapola: trapezio inferiore e dentato.
- Sintomi vascolari: medico.

Mandibola e respiro che tengono il collo

LA COMPONENTE DISCENDENTE

COSA DICE

- Serramento o bruxismo, dolore ai masticatori, click, cefalea alle tempie al mattino.
- Respira "con le spalle", sospira, fiato corto parlando, collo sempre in tensione.
- Il collo torna teso dopo ogni trattamento.

COSA VERIFICARE

- Apertura della bocca sotto le tre dita, deviazione, rumori, palpazione di masseteri e temporali.
- Schema respiratorio con mani su petto e pancia, espansione delle coste basse, BOLT, Nijmegen.
- Rivalutazione posturale con rulli salivari.

COSA LO ESCLUDE

- Mandibola libera e respiro basso: non è questa la via.

DIREZIONE DEL LAVORO

- Masticatori, respiro diaframmatico, suboccipitali.
- Dentista o gnatologo se l'occlusione cambia la postura.
- Senza questo, il cervicale si rifà teso.

Spalla

Tre domande separano quasi tutto: è rigida anche passivamente? È debole o solo dolente? Il dolore viene dal collo? Il resto lo fa l'età: instabilità sotto i 35, cuffia e capsulite fra i 40 e i 60, lesione a tutto spessore e artrosi oltre.

Bandiere rosse: ferma tutto e manda al medico

- **Riferito da organi.** Dolore alla spalla sinistra con sforzo, sudore, fiato corto: cuore. Spalla destra con dolore sotto le costole dopo i pasti: colecisti. Apice del polmone: dolore spalla e braccio in fumatore con calo di peso.
- **Lussazione non ridotta o frattura.** Trauma, deformità, impossibilità a muovere, crepitio osseo.
- **Lesione massiva della cuffia dopo trauma.** Oltre 40 anni, caduta, non riesce ad alzare il braccio da subito: ortopedico entro poche settimane, la riparazione ha una finestra di tempo.
- **Massa, febbre, rossore, dolore notturno non posizionale.** Tumore o infezione.
- **Deficit neurologico.** Perdita di forza non spiegata dal dolore, atrofia, scapola alata improvvisa.

L'ordine dei test, dopo le domande

1. **Collo prima**: movimenti del collo con sovrappressione e Spurling. Se cambiano il dolore alla spalla, torna alla sezione cervicale.
2. **Mobilità attiva e passiva**: elevazione, rotazione esterna con braccio al fianco, rotazione interna dietro la schiena, confronto con l'altro lato. Passivo limitato uguale all'attivo: capsula o articolazione. Attivo limitato con passivo libero: cuffia o dolore.
3. **Forza contro resistenza**: Jobe per il sovraspinato, rotazione esterna con gomito al fianco per infraspinato, lift-off per sottoscapolare. Dolente ma forte: tendinopatia. Debole: lesione.
4. **Test di provocazione**: Hawkins, Neer, arco doloroso per il dolore subacromiale; apprehension e relocation per l'instabilità; cross-body e palpazione per l'acromion-claveare.
5. **Scapola**: osservazione in elevazione, scapular assistance test, scapular retraction test. Se aiutare la scapola toglie il dolore, la causa è il controllo, non il tendine.

Dolore subacromiale, tendinopatia di cuffia

LA PIÙ COMUNE FRA 35 E 60

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore sul lato della spalla, a volte fino a metà braccio, mai sotto il gomito. • Peggio alzando il braccio, allacciando il reggiseno, dormendo sul lato. Lavori o sport con le mani sopra la testa. • Riesce a fare tutto, ma con dolore.	• Arco doloroso fra 60° e 120°. • Hawkins e Neer positivi, Jobe dolente ma forte. • Mobilità passiva completa. • Scapular assistance test: il dolore cala aiutando la scapola.	• Passivo limitato: capsulite o artrosi. • Debolezza vera: lesione. • Spurling positivo: cervicale.	• Carico progressivo della cuffia, non riposo: isometrici, poi rotazione esterna, poi elevazione. • Scapola: trapezio inferiore, dentato, piccolo pettorale. • Dorsale alto e postura: la stessa catena di Laura.

Lesione della cuffia a tutto spessore

OLTRE I 60, O TRAUMA

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Non riesce ad alzare il braccio, o lo alza "a scatti" aiutandosi con l'altro. • Debolezza più che dolore, dolore notturno, caduta o strappo in chi ha più di 40 anni.	• Drop arm positivo, lag della rotazione esterna (non tiene il braccio ruotato fuori), Jobe debole. • Lift-off o belly press deboli se c'è il sottoscapolare. • Tre fra: oltre 65 anni, debolezza in rotazione esterna, dolore notturno: molto probabile.	• Forza piena, solo dolore.	• Ortopedico e imaging. Nel giovane con trauma la riparazione è una scelta precoce. • Nell'anziano, se il chirurgo non opera, lavoro sul deltoide anteriore e sulla scapola per compensare.

Spalla rigida (capsulite adesiva)

40-60 ANNI, DIABETE, TIROIDE

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Prima dolore forte anche a riposo e di notte senza un motivo, poi rigidità crescente. • Non riesce a portare la mano dietro la schiena o a pettinarsi, da mesi. • Diabete, tiroide, periodo di immobilità.	• Rotazione esterna passiva con braccio al fianco ridotta oltre il 50% rispetto all'altro lato: è il segno chiave. • Elevazione passiva sotto i 100°, tutte le direzioni limitate, arresto capsulare. • Radiografia normale (il medico la chiede per escludere l'artrosi).	• Passivo libero: non è capsulite, qualsiasi cosa dica il dolore. • Artrosi alla radiografia.	• Fase dolorosa: niente forzature, mobilità nel comfort, scapola, dorsale. • Fase rigida: mobilizzazione progressiva, lavoro domiciliare quotidiano. • Tempi lunghi, da dire subito al paziente.

Instabilità gleno-omerale

SOTTO I 35, SPORT OVERHEAD

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• "Mi è uscita" una o più volte, oppure sensazione che "scappi" nel braccio alzato e ruotato fuori (lancio, nuoto, pallavolo). • Paura in certe posizioni più che dolore. • Ipermobile, lassità in altre articolazioni.	• Apprehension positivo e relocation che toglie la paura. • Sulcus sign, load and shift, Beighton per la lassità generale. • Forza di cuffia e controllo scapolare.	• Nessun episodio, nessuna apprensione, spalla stabile ai test.	• Cuffia e scapola in controllo, propriocezione, catena cinetica dal piede. • Niente allungamenti della capsula anteriore. • Lussazioni ripetute nel giovane: ortopedico.

Acromion-claveare

UN DITO SUL PUNTO

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Indica con un dito la cima della spalla, sull'articolazione. • Peggio portando il braccio verso l'altra spalla, dormendo sul lato, con panca e flessioni. • Caduta sulla spalla, o anni di palestra.	• Dolore alla palpazione dell'articolazione, cross-body adduction positiva. • O'Brien con dolore in cima, non dentro. • Arco doloroso alto, sopra i 150°.	• Articolazione non dolente alla pressione: quasi mai acromion-claveare.	• Scarico temporaneo dei gesti provocanti, mobilità della scapola e del dorsale. • Cuffia e trapezio inferiore per ridurre il carico sull'articolazione. • Separazione dopo trauma: ortopedico per il grado.

Capo lungo del bicipite e lesioni del labbro (SLAP)

SPORT DI LANCIO, LAVORI SOPRA LA TESTA

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore davanti alla spalla, lungo il solco, nel portare pesi con il braccio teso e nel lancio. • Click profondo, "qualcosa che si sposta" dentro, nel giovane sportivo.	• Speed e palpazione del solco bicipitale per il tendine. • O'Brien con dolore profondo, crank e biceps load per il labbro. Nessuno è decisivo da solo. • Deficit di rotazione interna nel lanciatore.	• Solco non dolente e test del labbro negativi.	• Capsula posteriore, scapola, cuffia in eccentrico. • Catena cinetica: anca e tronco nel gesto del lancio. • Sospetto di labbro nello sportivo: ortopedico.

Artrosi gleno-omerale

OLTRE I 60, O VECCHIO TRAUMA

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Rigidità e dolore profondo, crepitio, da anni, che peggiora piano. • Dolore notturno, perde le rotazioni prima dell'elevazione.	• Passivo e attivo limitati nelle stesse direzioni, con crepitio. • Rotazione esterna limitata come nella capsulite, ma con radiografia positiva e età più alta.	• Passivo libero. • Radiografia normale: è capsulite.	• Mobilità nel range disponibile, forza di cuffia e scapola, uso quotidiano. • Niente forzature sull'arresto osseo. • Ortopedico per il percorso.

Discinesia scapolare e postura

LA CAUSA DIETRO LE ALTRE

COSA DICE	COSA VERIFICARE	COSA LO ESCLUDE	DIREZIONE DEL LAVORO
• Dolore vago a spalla, trapezio superiore e fra le scapole, che va e viene con le ore allo schermo. • Spalle chiuse in avanti, "una spalla più bassa", stanchezza più che dolore acuto. • Tutti i test della cuffia sono borderline.	• Scapola alata o che sale in elevazione, asimmetria nel ritorno dalla elevazione. • Scapular assistance test e scapular retraction test: il dolore cala o la forza sale aiutando la scapola. • Forza di trapezio medio e inferiore, dentato anteriore. Lunghezza del piccolo pettorale. Mobilità dorsale in estensione.	• Scapola simmetrica e test di assistenza che non cambiano nulla: cerca nella struttura.	• Trapezio inferiore, dentato, piccolo pettorale, dorsale alto, cervicale basso. • Va fatto in ogni quadro di spalla, non solo in questo. • Lavoro posturale strutturato nel tempo: è la parte che fa durare il risultato.